

■ 脳卒中／血流制限

脳卒中の入院リハに血流制限トレーニング 3週間で下肢運動機能・歩行が上積み

96人の単盲検RCT 平均の差は小さく、長期の確認が必要

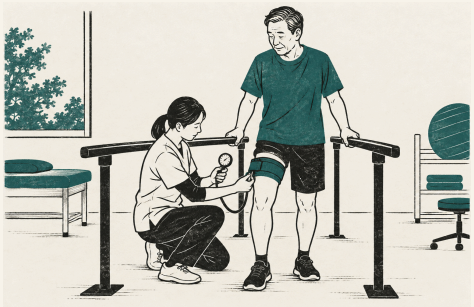
脳卒中患者に血流制限(BFR)トレーニングを加えると下肢の運動機能とバランスが良くなるかを調べた単盲検RCT。入院中の集中リハ病棟で、平均年齢55.8歳の96人を、通常の歩行、BFR歩行(カフ圧120mmHg)、BFR下の低負荷レジスタンス(20%1RM)に割り付け、週5回・3週間実施した。

全員が通常のリハも受けた。

主要評価のFMA-LEは、対照との調整後の差がBFR歩行で1.66点(95%CI 0.27～3.04)、低負荷BFRで2.25点(0.86～3.64)。BBS・TUG・30秒立ち上がりも両BFR群が上回り、重篤な有害事象はなかった。4点以上の改善は低負荷BFRで

34.4%、対照で15.6%だった。

平均の差は小さく、対象は比較的若い入院患者で追跡は3週間。著者も大規模・長期の試験を求める。回復期の高齢の方へそのまま当てはめず、循環の評価と合わせて検討したい。効果の大きさは追試で確かめる段階だ。



加圧の効果は小さく、条件を選んで確かめる

出典 Arch Phys Med Rehabil ↗

数字で見る

96人

脳卒中の入院患者

3週間

週5回の介入

2.25点

低負荷BFRのFMA-LE差

■ 脳卒中／転帰先予測

脳梗塞のNIHSS、3～7日目の評価が24時間以内より転帰先と強く関連

対象は、発症24時間以内に脳卒中集中治療室(SCU)へ入室し、発症時の住居が自宅だった脳梗塞患者172人(自宅退院103人、非自宅69人)。入室後24時間以内、3日目、7日目のNIHSSと転帰先の関係を比べた観察研究。

3日目と7日目のNIHSSは、24時間以内の評価より転帰先と有意に関連した。3日目と7日目の間に



差はなかった。抄録に効果量はなく、1施設で家族の介護力や住環境は扱っていない。申し送りでは3～7日目の値も確認したい。

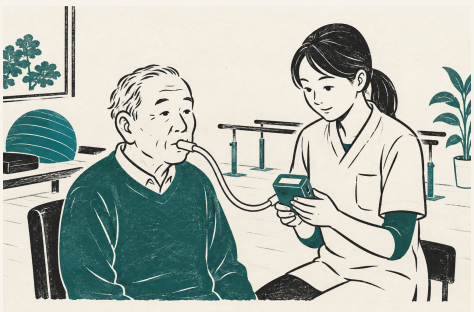
出典 理学療法科学 ↗

■ 回復期／嚥下・呼吸筋

運動器疾患52人、RSST回数が少ない人ほど 呼気筋力が低い傾向 回復期の横断研究

関中央病院などのグループが、回復期リハ病棟の運動器疾患患者52人(男性15人・女性37人)で、RSST、最大舌圧、握力、下腿最大周囲長、咳嗽時最大呼気流量(PCF)、最大呼気・吸気口腔内圧(PEmax・Plmax)を測定した。

RSST陽性群は呼吸機能の指標と最大舌圧が低く、RSST回数はPEmaxと



最も強く関連した。横断研究のため因果は不明で、1施設・52人。嚥下評価の際に呼気筋力も確認する、という使い方が妥当だ。

出典 理学療法科学 ↗

短信

〈転倒〉**反応抑制と転倒歴の比較**

地域高齢者90人の横断研究。ReacStickで反復転倒者を識別(AUC 0.80)。膝伸展筋力は保護的。

出典 Arch Phys Med Rehab ↗

〈認知AI〉**二重課題歩行で認知評価**

60歳以上201人の診断研究。歩行解析で認知障害の識別AUC 0.895。小集団の解析はばらつきが大きい。

出典 Arch Phys Med Rehab ↗

〈記録〉**PTの身体活動の記載**

初回評価1万件を解析。身体活動の記載は46%で、FITT全要素は9件(1%未満)。

出典 Arch Phys Med Rehab ↗

〈脊髄損傷〉**慢性痛の予測因子**

米国のSCI 1,303人の1年後解析。疼痛の予測は社会・人口学因子が最大。

出典 Arch Phys Med Rehab ↗

〈糖尿病〉**上肢リハの統合は不確実**

18研究835人を統合。握力差1.58kg(95%CI -0.06～3.22)で有意差なし。複合プログラムに期待。

出典 Disabil Rehabil ↗

〈めまい〉**rTMSとめまいリハ併用**

慢性前庭性めまい56人の二重盲検RCT。8週でBBSが6.3点改善。小規模で追試が必要。

出典 Arch Phys Med Rehab ↗

〈QOL〉**4つの生活の質プロファイル**

TBI・SCI・脳卒中・四肢外傷の患者を解析。診断をまたぐ4型に分かれ、疼痛や自立度が型を分ける。

出典 Arch Phys Med Rehab ↗

〈脊髄損傷〉**伴侶感と心理社会の関連**

外傷性SCI 1,810人の横断研究。伴侶感が、婚姻状況と抑うつ・生活満足度の関連を媒介した。

出典 Arch Phys Med Rehab ↗